

Dyspnée

incapacité respiratoire subjective (gêne respir, gêne à l'effort, essoufflement) → sensation désagréable

PAS forcément lié à une modification du système respiratoire (MAIS souvent dyspnée + tachypnée)

→ Signe Fonctionnel vs Signe Physique (bruits de respiration / palpitations)

Anamnèse ARC IDATIC

A récurrente - dyspnée

Rythme & fréquence

Causée - brutes, progress, passives

Irradiation sous quelle forme

Déclencheur - à l'effort, couché

Associé Symptômes - expectorations

Temps évolution - constant / croissant / diminuant avec le temps

Influence respiratoire d'anxiété

Contexte de Survenue - ATCD / médicaments

Motivité = Antidromique
Nocturne - débit nasal = OAP
fin nuit = Asthme

Fréquence
Bradypnée < 10 cpm
Physiologie 12-16 cpm
Tachypnée > 25 cpm
Volume
Hyperpnée = V_{max} ↑
Hypo-pnée = V_{max} ↓

Dyspnée Aiguë

Récit & Brutal

Aggravation rapide

Dyspnée Chronique

> 8 semaines & progressif

Aggravation lente

EvA
↓
Anxiété - Respir

Echelle de BORG
↓
Chronique → après tout l'effort (0-10)

Asténie / Elapsoir bronchique = Pertes tonus & extensibilité
→ Elapsoir & asténie
→ Plus en extension trouble

INSPECTION

Respiration paradoxale → atténue & p. accessoire → bruits Abdominal & = Vents ou crasse à l'inspiration
F₁
P₁ = Vents ou griffes à l'inspiration

Dyspnée Inspiratoire
↓
obstacle voie respiratoire
asthma - thoracique
K₁ Thoracique
↓
Sous-épigastrique / Epigastrique
Bruit : crépitation / wheezing

Dyspnée Expiratoire
↓
obstruction intra-thoracique
Asthma
BPCO
OAP
Expiratoire sifflante

PALPATION & PERCUSSION

Tympanisme = Pneumothorax ou Emphysème
Matité = Empaïssement liquidien ou condensation pulmonaire

AUSCULTATION

Physiologique = murmure vésiculaire

Pathologique =

Aigus : Sibilants ("sifflant central") & Strides
Grosses : Ronchi ("mouvement central")

Rales crépittants ("bells de verre")
Rales sans crépittants - OAP

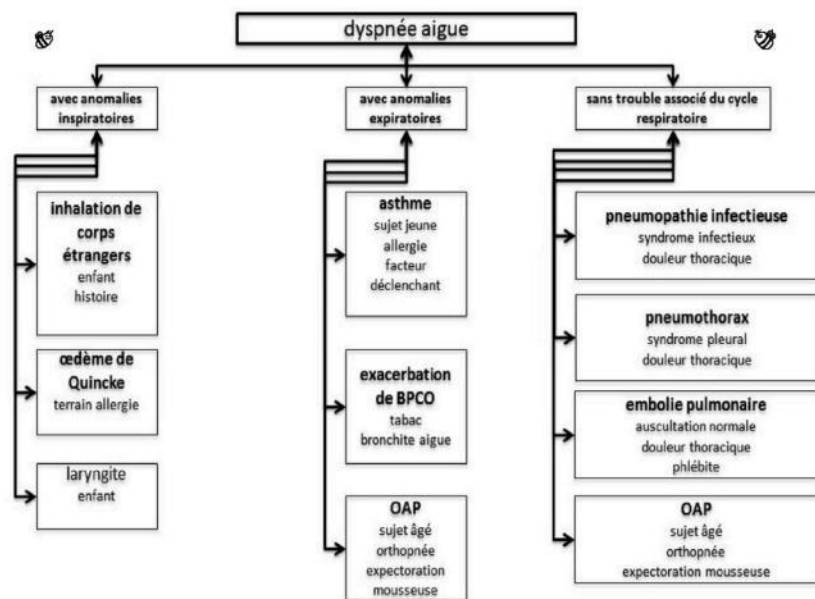
Echelle MRC

↓
Pneumologie → Maladies chroniques

Echelle NYHA

↓
1-4 grade fonctionnel chez les cardiologues

QUANTIFIER la Dyspnée:



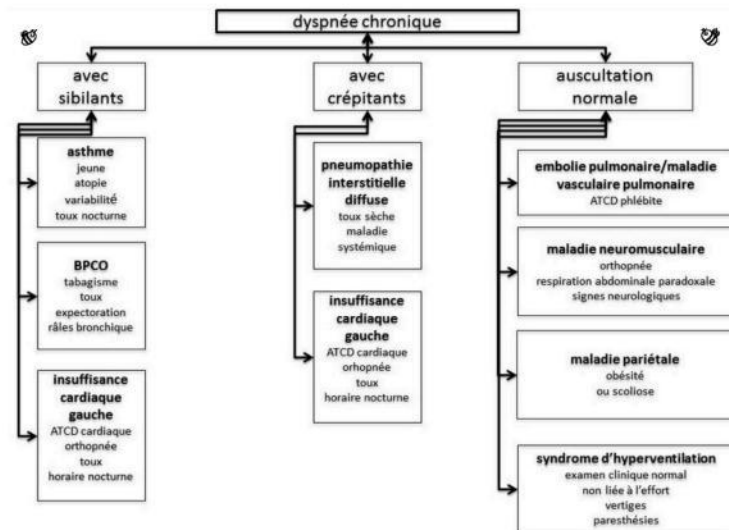
Inhalation de corps étrangers : principalement dans les voies aériennes extra thoraciques pour donner une dyspnée inspiratoire.

Œdème de Quincke : œdème des voies aériennes supérieures.

Laryngite/épiglottite chez l'enfant : ne surtout pas allonger ! Risque de décès.

Exacerbation de BPCO : épisode aigu chez un patient ayant une BPCO (BronchoPneumopathie Chronique Obstructive, qui est une maladie chronique). La cause de cette exacerbation est souvent une infection souvent virale.

OAP : œdème aigu pulmonaire cardiogénique.



On va établir que c'est une dyspnée chronique (8 semaines), la caractériser avec l'interrogatoire et à l'examen on aura comme informations les bruits (continus, discontinus, aigus, graves, etc). On a des informations sur le patient, sur son symptôme et ses détails, ses antécédents, sur sa caractéristique de sa dyspnée, sur son examen physique, qu'on va additionner et faire du raisonnement bayésien.

Pneumopathie interstitielle diffuse : il s'agit souvent d'une fibrose pulmonaire idiopathique.

L'insuffisance cardiaque gauche : provoquera souvent des **crépitants** avec une tonalité différente de celle de la pneumopathie interstitielle diffuse.

Maladie neuromusculaire : Le murmure vésiculaire peut être diminué car le patient n'arrive pas à mobiliser sa cage thoracique.

Syndrome d'hyperventilation inappropriée : diagnostic d'exclusion. Souvent, on ne retrouve pas de cause précise.

Pour la dyspnée chronique, la distinction se fait par les anomalies à l'auscultation.

Râles sibilants = sifflement, **bruits expiratoires aigus continus**.

Râles crépitants = craquement, bruits discontinus qu'on entend souvent plus à l'inspiration.

Douleurs thoraciques aiguës et chroniques

Particularité : { Pneumonie + Pleurite Viscérale } n'ont pas d'inspiration caractéristique
Symptômes Tumoureux tardifs

Antécédents de la douleur — Aiguë? Chronique?

Rythme et fréquence — Essentiel? épisodique?

Caractéristique → Intensité — 1-10

- Irradiation — douleur Aorte = Transversalement
— douleur pleurales = épaulée ou hypochondrique
- Type — constricteur (SCA) / piquant (embolie / pleurite)
- Irradiation — à l'épaule / claque de dentier
- Evolution — constant!
- Traitements — ATCD, Tabac, alcool, HTA

URGENCE : "T-PIED"

Temporade cardiaque = Péricardite éssentielle comprimant le cœur
+/- douleurs thoraciques
Dyspnée + Étiologie

Péricardite "classique" non urgent : Signe douleurs thoraciques Antérieurs
atténués si on se penche en avant.

Pneumothorax → Pneumothorax spontané idiopathique suffisant
"Effet Sappey" → Ai mal dans la pleur à l'inspiration → Ai mal au repos à l'expiration
Compressif + 5 Anxiété cardiovasculaire!
→ Taux d'Etiologie

Infarctus du myocarde = Syndrome Coronarien Aigu (SCA) — 1/3 des syndromes thoraciques

- douleur intense, médiastino-sternale compressive, ↑ à l'effort et ne cède pas aux nappes, Irradiation Mâchoire et Membres supérieurs gauche
- ↳ Signes QT+ → onde Q creuse + négative
- ↳ Coronaryographie → Stent
- et Traitements

Dissection Aortique

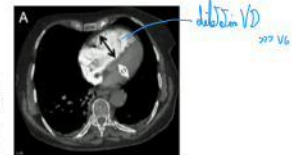
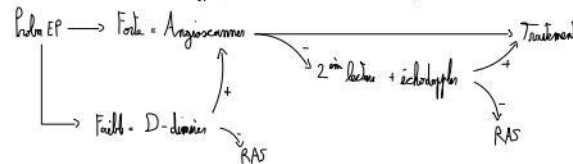
↳ Hématome intima-média

.....> douleurs intenses
Médiane, rétrosternale
Transversalement (visibilité visible de la cage de contour)

EP : Embolie Pulmonaire : obstruction partielle pulmonaire par un thrombus des veines des membres inférieurs

Score WELLS + GENÈVE

Douleur type "piquant" : douleurs thoraciques, majorées à l'inspiration et à la toux



D-dimères = marqueurs fibrinolytiques
↑ coagulation
= D-dimères

Signes généraux

- Asthénie = fatigue normale
↓
physique ou psychique
- TCA: troubles comportementaux

- Modification masse $\rightarrow$ IMC = $\frac{\text{Poids}}{\text{Taille}^2}$

Distribution $\int$ normal $\int$ Surpoids ...
18,5 25 30 35 40

$\rightarrow$ Composition corporelle "Asthénisme Respiratoire"

Sous-poids: poids normal MAIS sans muscle

Conclusion: $\forall$ IMC on $\downarrow$ masse muscle

- La Fièvre $> 38^\circ$
 - en Plateau - infection aigüe, inflammatoire, X
 - en Pic Élévé - infection bactérienne
 - Descentes - Abcès $\rightarrow$ abcès $\rightarrow$ abcès $\rightarrow$ abcès $\rightarrow$ abcès
 - Élévée - tubercule

Déformation du thorax

 Pectus Excavatum
 Pectus Carinatum

- Syndrôme Cœur Supérieur: Échec VCS $\rightarrow$ Veines superficielles

Auscultation

Diminution ou Abolition de murmure vésiculaire $\rightarrow$ Diffuse = BPCO / Asthme
 Localisation: Atelectasie (obstruction bronchique) / muco / épanchement pleural

Souffle tubaire = Rude / Fort / Sustenté on inspiration = le son résonne dans les bronches (Normalement non transmis; Atelectasie $\rightarrow$ transmission $\rightarrow$ transmission)

$\hookrightarrow$ condensation pulmonaire / Atelectasie compressive / OAP localisé

Souffle Pleurétique = Doux / Faible / court = le son des fausses pleures ne glisse plus / ne sonne pas "bulle" $\rightarrow$ Pleurésie Sicile / Embolie

Souffle Amphique = creux / résonant = Air résonne dans une cavité $\rightarrow$ Pneumothorax / cavité tuberculeuse

Sibilants = sons sifflants expiratoires aigus = Obstruction Bronchique Moyenne $\rightarrow$ BPCO / Asthme

Roules = sons graves continus et soufflants = Sécrétions épaisses retenues dans les Grosses Bronches $\rightarrow$ Bronchite chronique / Muco abondant

Strôles = sons aigus très intenses inspiratoires = Obstruction Voies Aériennes Supérieures $\rightarrow$ Corps étrangers, laryngite, X

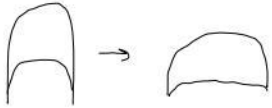
Râles crépitaux = Sec, discontinus, inspiratoires = ouverture bruits des alvéoles $\rightarrow$ Edème, OAP, Pneumonie interstitielle

Râles sous-crépitaux = Sec, discontinus, "graves", inspiratoires $\rightarrow$ muco floc, l'air le fait bulle $\rightarrow$ OAP, Broncholite, BPCO

Squeak = aigus, très court

La Distension Thoracique

Déformation du thorax qui s'aplatit "en cloche"



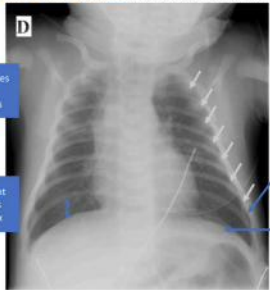
Aplatissement des coupes Φ

+ Augmentation espaces clairs intercostaux

+ Signe de Harrison (le diamètre transversal diminue $\searrow$ à l'âge)

CFD: Φ aplati = constat

Radiographie de thorax de face (nouveau-né de 21 jours avec bronchiolite)



Hyperclarté des bases pulmonaires

Élargissement des espaces intercostaux

Plus de 6 arcs costaux antérieurs (flèches grises) visibles au-dessus de la coupole diaphragmatique

Aplatissement des coupes diaphragmatiques



Radiographie normale chez un enfant d'âge similaire

Distension thoracique

Cyanose = coloration violet due à la désoxyhéoglobine

Cyanose Centrale Chaude

Signe } $S_pO_2 \searrow$ (80-85%)
Anomalie Hémation }
 $\searrow O_2 / Imp$

Visible + à l'effort $\searrow$ Polyglobulie $>$ Anémie

+ de Hb-décoloré
= + vite guéri

Cyanose Périphérique Froide

IC, S^o Raynaud } Stase veineuse
Compression vasculaire

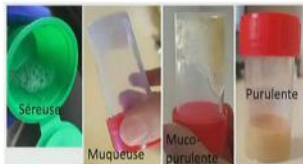
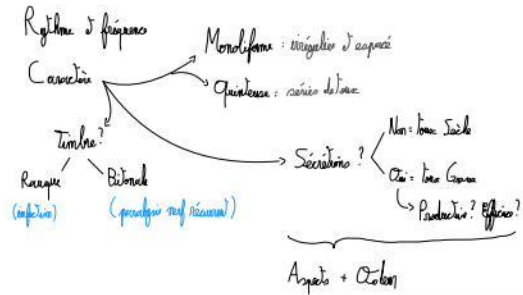
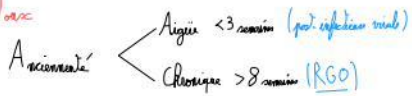
Hypoplasie digitale

cause microcisme $\rightarrow$ élargissement des phalanges,
déformation des orteils,
Dactylomégalie (délég),
Inhibe



Apparait dans des troubles pulmonaires: K, fibrose pulmonaire, bronchoectasie (dilat^o et surinfect^o d'une bronche)

Toux



Installation - début / passage

Durée - durée ? Changement de position → Épanchement pleural dépendant

Aspect & symptômes

Temps d'incubation - semaine ? aggravation ?

Influence environnemental / saison - vent / chaleur / printemps - Allergie

Contexte - ATCD

Hémoptysie

Régime de sang d'origine respiratoire inférieure lors d'un effort de toue.

Urgence liée à l'abondance :

- Faible < 50cc (ml)
- Moyenne 50 à 200 cc
- Grave > 200cc ou > 500cc précisions sur 24h

Urgence liée à l'insuffisance respiratoire :

- Installation rapide asynchrone → Malade !
- Relève... Hémoptysie Symptôme : faiblesse abdominale MAIS cause mortelle

⚠ ≠ Hémoptysie ni Épistaxis Digestive

Sang dans l'écoulement

Traitement :

[Endoscopie + produit fibrinolytique]

Endoscopie via Artère fémorale

Pleurésie

Épanchement liquidien dans la plèvre

TRANSUDAT

Rénal, déséquilibre Bessier-Hypertension & Cholestase

EXSUDAT

Urgence = Inflammation
infectieuse / néoplasique

SAHF : faible albumine ou IC gauche connue

Position sous la pointe de la Scapula
dorsale Scapulaire

DIFFÉRENCIER TRANSSUDAT ET EXSUDAT		
PONCTION PLEURALE	Non-dit cette année : Non systématique. On prélève du liquide avec une aiguille puis on l'envoie en analyse. On mesure ensuite les <u>protides</u> contenus dans le liquide pleural ponctionné.	
	PROTIDES (g/L)	⊗ Critères complémentaires (dits de Light) ⊗ Nature de l'épanchement.
	< 25	NON. Transsudat.
⊗ 25 à 35 ⊗	⊗ LDH > 200 UI/L ⊗	Si non = transsudat. Si oui = exsudat.
	> 35	NON. Exsudat.
PRISE EN CHARGE	Dans le cas d'un exsudat, on vide la collection de liquide.	
	Dans le cas d'un transsudat, on traite la cause sous-jacente.	

CAUSES :

liquide clair et rose

Transsudat → IC gauche = OAP + épanchement pleural (MP_{gauche})

→ Cholestase = Hypertension Portale → Ascite

protéine de l'albumine → pleurésie (Pression - osmose)

Néphrose & lésion rénale

Albuminurie, Émolyse

liquide trouble / Sero-hématique

exsudat → pleurésie néoplasique X [Métastases - kystes]

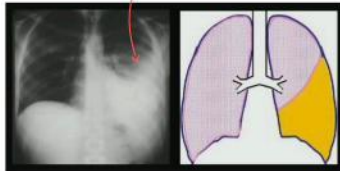
→ infectieuse

→ Auto Immune

5^{es} : Douleurs { Apparition brutale
Homotélorale
Lent - Interactif / Postérieur ... Jamais médian
Rythme par la toux

+ Dyspnée + Toux + Fièvre + Examen Physique { Abolition transmission vibrations vocales ("33" Palper s'arrête : effacement STP du liquide) ~ in chape avec l'Air (PVo)
Matité basale - Δ ne pas confondre abolition "Attouché"
Abolition murmure vésiculaire

Examen : Radiographie = ligne de Dornier



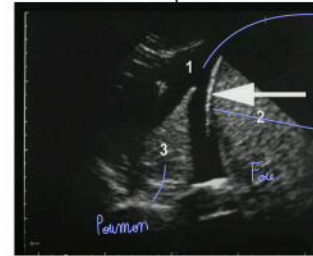
Ligne de Dornier : ligne courbe → limite Pleur

liquide → ⊙ de résorption sur les bords = S'ACCUMULE là !

Présent = épanchement liquidien moyen

Absence → ligne horizontale = Hydrothorax (Air Arrêté à l'entrée & qui ne peut pas passer)
→ Pleurésie Exsudative = poche

Echographie



liquide blanc (1)

II = Hypertension

Syndrôme Cerve Supérieur

- Obstruction VCS → Turgescence des veines jugulaires
 - Œdème en pélican (1 œil)
 - Œdème de la face
- Circulation Veineux Cérébral
- Hypertension intracrânienne : céphalées

Syndrôme Parcoast & Trous

- Tumeur Apex Pommor → douleurs à l'épaule et membre supérieur
 - atrophie p de la main
 - ostéofus costal
- Signes de Claude-Bernard-Horner
 - ↳ ganglion & cervical inférieure (stellum errant)

(
Myosis (cœur) pupille
Ptosis (paupière tombée)
Enophthalmie (œil qui rentre)

Atteinte:

- nef pharyngée → Hoquet (nœuds et diaphragme)
- nef laryngotrachéale → Dysphonie
- trachée bronchale → douleurs cervico-brachiales
- ganglion inf & → Claude Bernard Horner